

Abdominelle Infektionen

Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektiologie
Florian Hitzenbichler

ABS Fellow Team West Online

23.06.2026

IAI - Grundlagen

The Surgical Infection Society Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection: 2024 Update

Jared M. Huston,¹ Philip S. Barie,² E. Patchen Dellinger,³ Joseph D. Forrester,⁴ Therese M. Duane,⁵
Jeffrey M. Tessier,⁶ Robert G. Sawyer,⁷ Miguel A. Cainzos,⁸ Kemal Rasa,⁹ Jeffrey G. Chipman,¹⁰
Lillian S. Kao,¹¹ Frederic M. Pieracci,¹² Kristin P. Colling,¹³ Daithi S. Heffernan,¹⁴ and Janice Lester¹⁵;
Therapeutics and Guidelines Committee

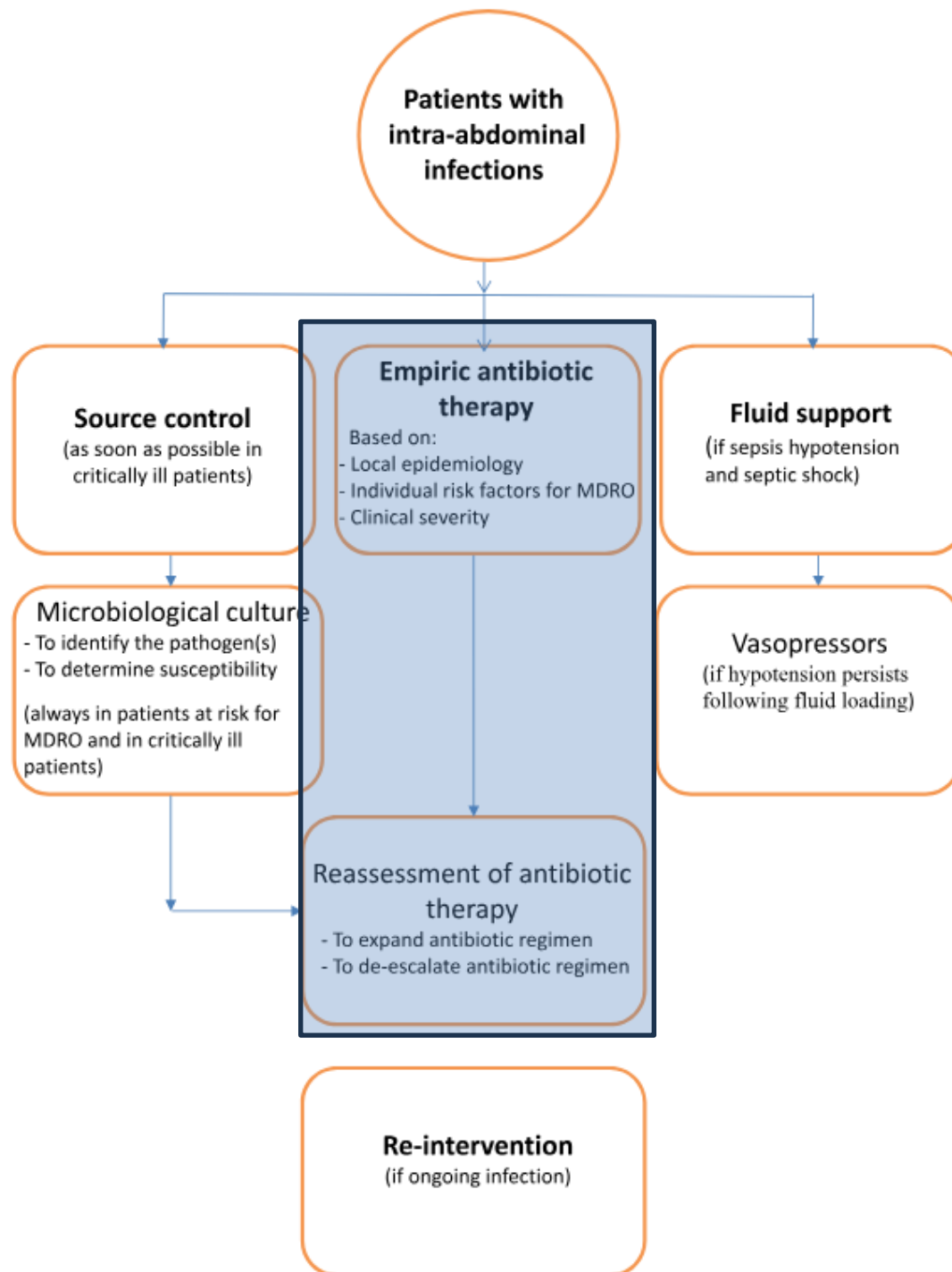
WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections

Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery 2021

Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Infektionen: Intraabdominelle Infektionen

PEG-Intraabdominelle Infektionen,
Eckmann et al

Drei Säulen der Therapie von intraabdominellen Infektionen (IAI)



„There is a tendency in the discussion of infectious disease to forget, or rather downplay, that an [intraabdominal infection is a surgical disease](#).“

R.G. Sawyer

(Chirurg)

Primär	Sekundär		Tertiär
Spontan bakterielle P. (SBP) oder CAPD	Ambulant erworben	Nosokomial	
~ 1%	80-90%		< 10%
Translokation	Perforation Hohlorgan	Postoperativ erworben, zB Anastomosen-insuffizienz	Persistenz der Peritonitis nach adäquater Fokussanierung
(oft) Monoinfektionen, v.a. <i>E. coli</i>	Mischinfektionen selten MRE	Mischinfektionen , mit MRE ist zu rechnen (ESBL/AmpC, VRE, MRGN)	
IdR <u>keine</u> chirurgische Therapie erforderlich	Chirurgische Therapie zur Fokussanierung erforderlich		IdR <u>keine</u> chirurg. Therapie erforderlich / möglich

Definition tertiäre Peritonitis Rezidiv oder Persistenz der Peritonitis **48h** nach eigentlich adäquater Fokussanierung
alternativ ein fließender Übergang von sek. zu tertiär zur Beschreibung der „kränksten“ Patienten

Primär	Sekundär		Tertiär
Spontan bakterielle P. (SBP)	Ambulant erworben	Nosokomial	nosokomial
Ceftriaxon Pip / Taz	Ohne MRE Risiko: Amoxi/Clav Ampi/Sulb Cipro / Metronidazol Mit MRE Risiko: Piperacillin / Tazobactam Meropenem	Piperacillin / Tazobactam Meropenem +/- Vancomycin / Linezolid +/- Echinokandin (<i>insb. bei Leckage oberer GI Trakt, Immunsuppression, septischer Schock</i>)	Nach Erregernachweis Hohes Risiko MRGN, VRE, Candida

MRE Risiko:

- Postoperative Peritonitis
- Tertiäre Peritonitis
- Antibiotikavorthherapie anderer Erkrankungen (z.B. infizierter diabetischer Fuß)
- Verlegung aus Land/Region mit hoher Prävalenz resistenter Erreger
- Patienten mit häufigen Auslandsreisen in Länder mit hoher MRE-Prävalenz
- Bekannte MRE-Kolonisation des Magen-Darm-Trakts
- (Medikamentöse) Immunsuppression
- Verlängerter Krankenhausaufenthalt/Intensivstationsaufenthalt

Diagnose	Häufige Erreger	Therapieempfehlung	Tagesdosis
Ambulant erworben keine Perforation minimale Peritonitis kreislaufstabil kein MRE-Risiko (Bsp.: phlegmonöse Appendizitis)	Enterobacteriaceae Anaerobier Enterokokken	Cefuroxim + Metronidazol Cefotaxim + Metronidazol Ceftriaxon + Metronidazol Ciprofloxacin + Metronidazol Levofloxacin + Metronidazol Ampicillin/Sulbactam Amoxicillin/Clavulansäure Moxifloxacin	3x 1,5 g + 3x 0,5 g 3x 2 g + 3x 0,5 g 1x 2 g + 3x 0,5 g 2x 0,4 g + 3x 0,5 g 1x 0,5 g + 3x 0,5 g 3x 3 g 3x 2,2 g 1x 0,4 g
Ambulant erworben frische Perforation lokalisierte Peritonitis kreislaufstabil kein MRE-Risiko (Bsp.: perforierte Cholezystitis)	Enterobacteriaceae Anaerobier Enterokokken	Cefuroxim + Metronidazol Cefotaxim + Metronidazol Ceftriaxon + Metronidazol Ciprofloxacin + Metronidazol Levofloxacin + Metronidazol Ampicillin/Sulbactam Amoxicillin/Clavulansäure Moxifloxacin	3x 1,5 g + 3x 0,5 g 3x 2 g + 3x 0,5 g 1x 2 g + 3x 0,5 g 2x 0,4 g + 3x 0,5 g 1x 0,5 g + 3x 0,5 g 3x 3 g 3x 2,2 g 1x 0,4 g
Ambulant erworben ältere Perforation diffuse Peritonitis kreislaufstabil individuelles MRE-Risiko (Bsp.: frei perforierte Sigamdivertikulitis)	Enterobacteriaceae Anaerobier Enterokokken	Piperacillin/Tazobactam Ertapenem Tigecyclin Moxifloxacin Ceftolozan/Tazobactam + Metronidazol	3x 4,5 g 1x 1–2 g 2x 0,05 g* 1x 0,4 g 3x 1,5 g + 3x 0,5 g
Nosokomial (postoperativ/tertiär) diffuse Peritonitis kreislaufinstabil hohes MRE-Risiko (Bsp.: Nahtleckage nach Rektumresektion)	Enterobacteriaceae (inkl. ESBL-Bildner) Enterokokken (inkl. VRE) Anaerobier <i>Pseudomonas</i> spp. Staphylokokken (inkl. MRSA)	Tigecyclin* Meropenem (+ Linezolid) Imipenem (+ Linezolid) Ceftolozan/Tazobactam + Metronidazol (+ Linezolid) Ceftazidim/Avibactam + Metronidazol (+ Linezolid) Fosfomycin (keine Monotherapie)	2x 0,05–0,1 g* 3x 2 g (+ 2x 0,6 g) 3x 1 g (+ 2x 0,6 g) 3x 1,5–3 g + 3x 0,5 g (+ 2x 0,6 g) 3x 2,5 g + 3x 0,5 g (+ 2x 0,6 g) 3x 4–8 g

 PEG-Intraabdominelle Infektionen,
 Eckmann et al

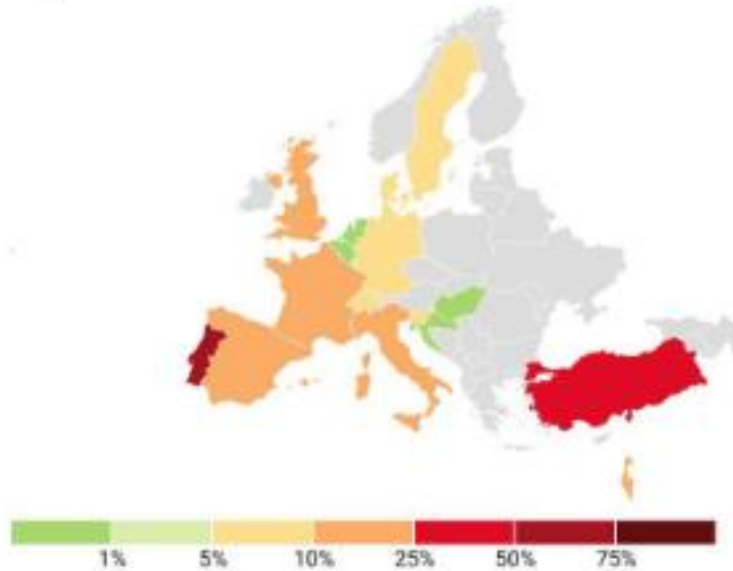
Erreger

Anaerobier

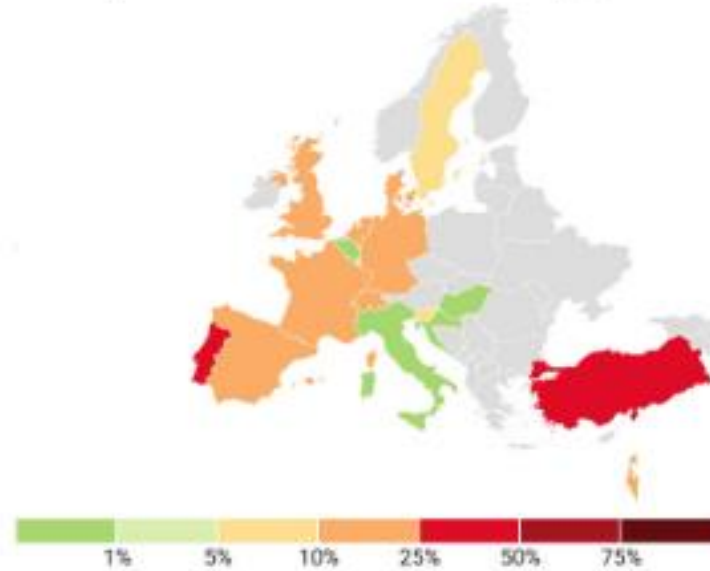
Lokalisation	Bakterienzahl/ml	Aerobier / Anaerobier	Pathogene
Mundhöhle			Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp., Peptostreptococcus spp.
Speichel	$10^8 - 10^9$	1 : 1	
Gingivaspalten	$10^{11} - 10^{12}$	$1 : 10^3$	
GI Trakt			Bacteroides spp. (B. fragilis!), Prevotella spp, Clostridium spp., Peptostreptococcus spp.
Magen	$0 - 10^5$	1 : 1	
Dünndarm	$10^4 - 10^7$	1 : 1	
term. Ileum bis Kolon	$10^{11} - 10^{12}$	$1 : 10^3$	

Aus Kasper & Cohen-Poradosu, Harrison 18. Auflage

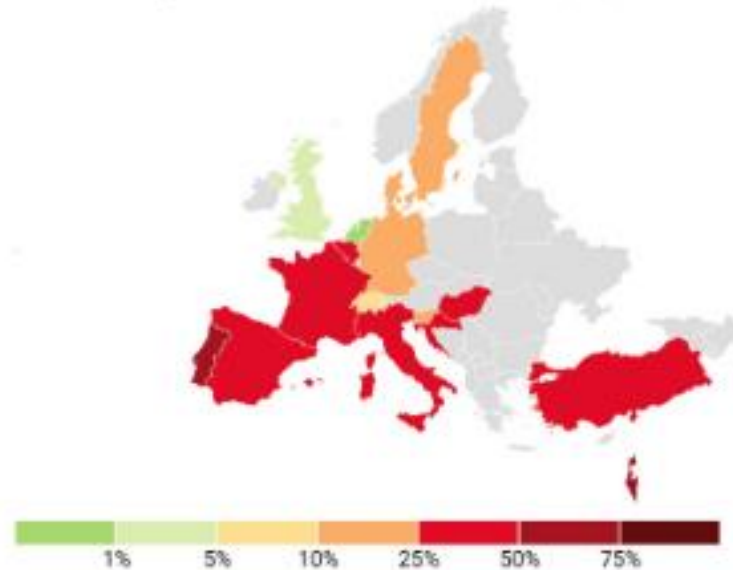
(A) Piperacillin-tazobactam resistance rates (%)



(B) Meropenem resistance rates (%)



(C) Clindamycin resistance rates (%)



(D) Metronidazole resistance rates (%)



449 Blutkulturoisolate
von *B. fragilis* aus 16
Europäischen
Laboren aus dem Jahr
2022;

CAVE: nur unter 50
Isolate aus
Deutschland

Antibiotic	Anaerobic coverage
Amikacin	–
Amoxicillin/ clavulanate	+
Ceftazidime/ avibactam	–
Ceftolozane/ tazobactam	–
Cefotaxime	–
Ceftazidime	–
Ceftriaxone	–
Ciprofloxacin	–
Eravacycline	+
Ertapenem	+
Imipenem-cilastatin	+
Meropenem	+
Metronidazole	+
Piperacillin/ tazobactam	+
Tigecycline	+

Antibiotic	Anaerobic coverage	JNG.
Amikacin	—	
Amoxicillin/ clavulanate	+	
Ceftazidime/ avibactam	—	
Ceftolozane/ tazobactam	—	
Cefotaxime	—	
Ceftazidime	—	
Ceftriaxone	—	
Ciprofloxacin	—	
Eravacycline	+	
Ertapenem	+	
Imipenem-cilastatin	+	
Meropenem	+	
Metronidazole	+	
Piperacillin/ tazobactam	+	
Tigecycline	+	

➤ Risikofaktoren

- Oberer GI Trakt (Ösophagus, Duodenum, Dünndarm)
- Wiederholte Revisionen
- Anastomoseninsuffizienz

➤ Diagnose mittels mikrobiologischer Kultur von Peritonealflüssigkeit

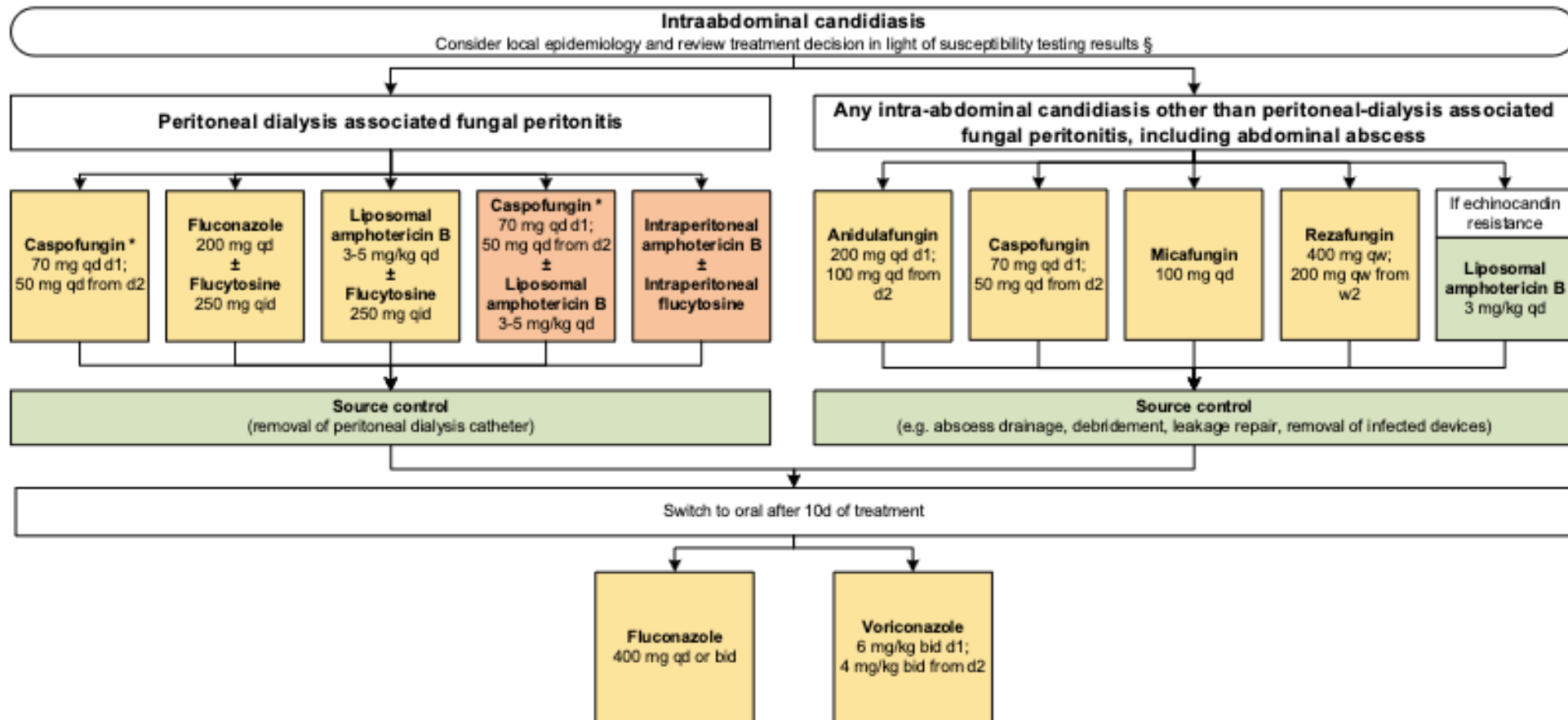
➤ Möglichst **keine** Kultur von länger (>24h) liegenden Drainagen (hier häufig Candida Nachweis im Rahmen der Fremdkörperbesiedelung)

➤ Beta-D-Glukan (BDG) mit hohem negativ prädiktivem Wert (u.a. Clancy et al, J Fungi 2021)

- Optimale Therapie: Fluconazol **S** ➔ Fluconazol, Fluconazol **R** ➔ Echinokandin
- **Echinokandine:**
 - Hydrophil, hohe Proteinbindung
 - Zunehmende Hinweise auf Unterdosierung in Intensivpatienten (allerdings PK Analysen, keine klinischen Daten!)
 - Schlechte Peritonealpenetration (etwa 0,3)
- **Fluconazol**
 - Hydrophil, niedrige Proteinbindung, abh. von Verteilungsvolumen
 - RF für Unterdosierung: Adipositas, erhöhte renale Clearance, Dialyse
 - Rel. gute Penetration in den Aszites (0.85), sehr gute Penetration in das Pankreas
- **Neue Substanzen**
 - **Rezafungin:** einmal wöchentliche Gabe, Spektrum ähnlich dem Anidulafungin, gute Peritonealpenetration, Daten zu Intensivpatienten??

Candida

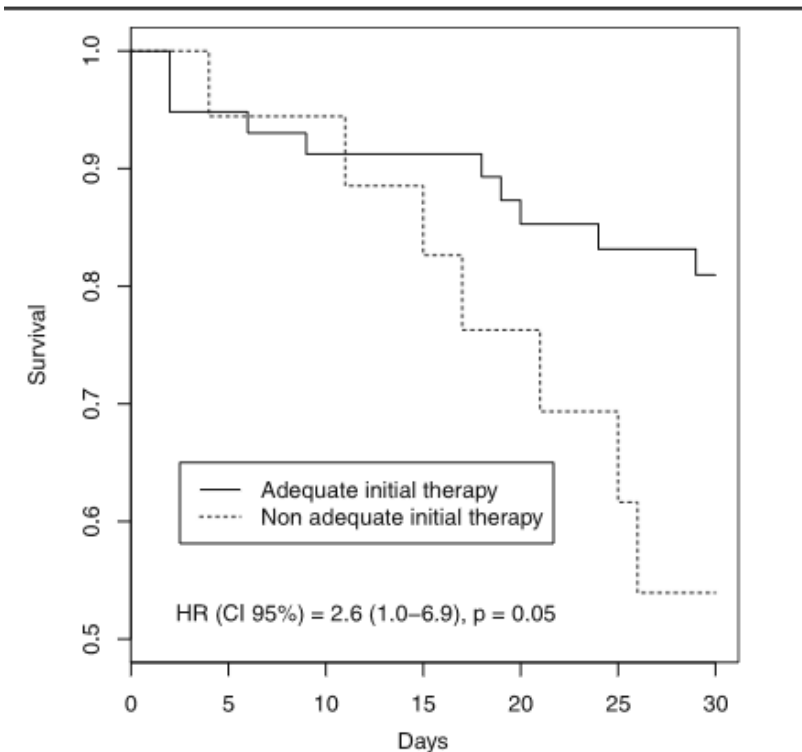
Figure 23. Optimal treatment pathway for intra-abdominal candidiasis in adults when all treatment modalities and antifungal drugs are available.



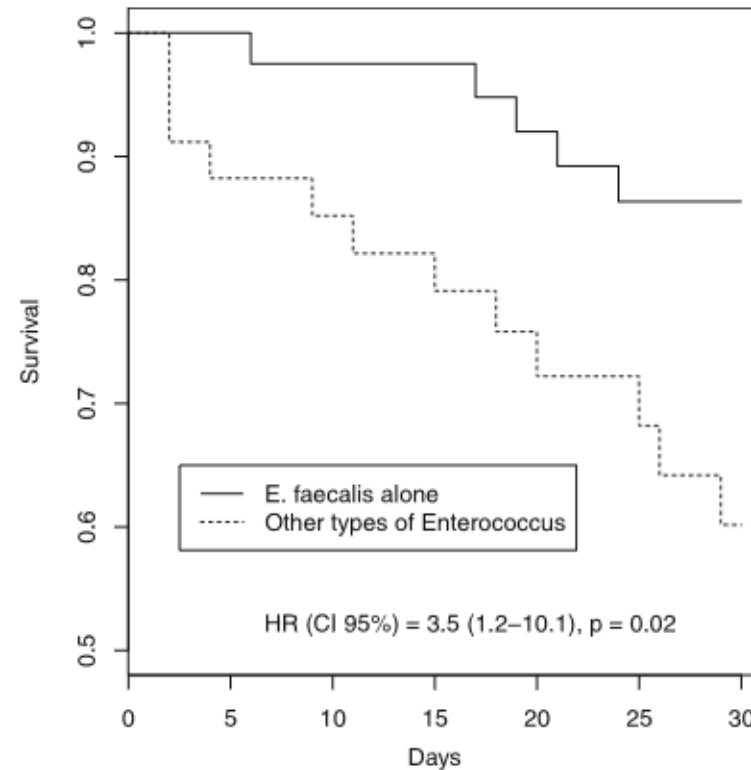
- Rolle der Enterokokken weiter unklar
- Gerade im Setting CA-Peritonitis trotz Nachweis oft nicht relevant
- Im Setting **postoperative Peritonitis** jedoch in der Regel „behandlungsbedürftig“
 - U.a. Metaanalyse *Cercenado et al, J Clin Micro 2010*
 - Enterokokken tatsächlich pathogen oder nur Epiphänomen der kranken Patienten?
- **Optimale Therapie:**
 - *E. faecalis*: Ampicillin, Piperacillin
 - *E. faecium*: Vancomycin
 - VRE: Linezolid, Tigecyclin

Retrospektive Analyse, franz. OutcomeRea Datenbank,
Patienten mit (amb. und nosok.) IAI und
Enterokokkennachweis kulturell peritoneal

8% der Patienten mit IAI



Impact of species and antibiotic therapy of enterococcal peritonitis on 30-day mortality in critical care—an analysis of the OUTCOMEREA database



Therapiedauer

STOP IT Trial

518 Patienten mit kompl. IAI, randomisiert,
 open-label
 AB Therapie **für 4d** (+/- 1) vs. AB **für max. zehn**
Tage (oder alternativ 2 Tage **nach**
 Normalisierung Temp. / Leukos / BB)
 Alle mit **adäquater** Kontrolle der Infektion

Allerdings:
 Apache Score II ~10
 1/3 der Patienten mit interventioneller
 Drainage (ohne OP)

	Usual care	4d	
Surgical-site infection	23 (8.8)	17 (6.6)	0.43
Recurrent intraabdominal infection	36 (13.8)	40 (15.6)	0.67
Death	2 (0.8)	3 (1.2)	0.99
Time to event — no. of days after index source-control procedure			
Diagnosis of surgical-site infection	15.1±0.6	8.8±0.4	<0.001
Diagnosis of recurrent intraabdominal infection	15.1±0.5	10.8±0.4	<0.001
Death	19.0±1.0	18.5±0.5	0.66
Duration of outcome — days			
Antimicrobial therapy for index infection			<0.001
Median	8	4	
Interquartile range	5–10	4–5	
Antimicrobial-free days at 30 days			<0.001
Median	21	25	
Interquartile range	18–25	21–26	



249 Intensivpatienten, multicenter, Frankreich, randomisiert, 8d vs. 15d

Alle mit adäquater Fokuskontrolle bei postoperativer sekundärer Peritonitis

Primärer Endpunkt: Antibiotika-freie Tage an Tag 28

Sekundärer Endpunkt: Tod, ICU und KH Verweildauer, MDR Auftreten

Take-home message

This multicentre prospective randomised study evaluated the efficacy and safety of an 8-day course of antibiotic therapy in ICU patients treated for postoperative intra-abdominal infections. This regimen substantially reduced antibiotic exposure and no clinical benefit was observed when treatment was extended to 15 days.

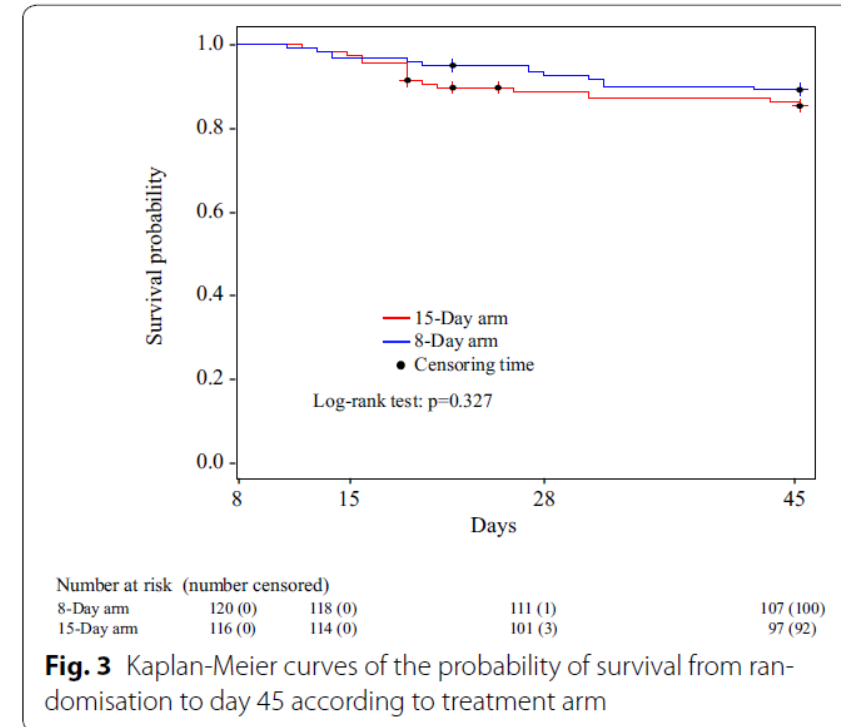


Fig. 3 Kaplan-Meier curves of the probability of survival from randomisation to day 45 according to treatment arm

Primary and secondary outcomes	15-day arm (n=116)	8-day arm (n=120)
Primary outcome		
Antibiotic-free days on Day28, median [IQR] ^a	12 [6—13]	15 [6—20] $p<0.001$
Secondary outcome		
Length of ICU stay between Day0 and Day45, median [IQR] ^b	12 [7—20]	13 [7.75—25]
Length of hospital stay between Day0 and Day45, median [IQR] ^c	30 [20—45]	30.5 [18.75—45]

Reduktion
Antibiotikaeinsatz
um drei Tage

Diagnose	Therapiedauer	EG
Ambulant erworben keine Perforation minimale Peritonitis kreislaufstabil kein MRE-Risiko (Bsp.: phlegmonöse Appendizitis)	1 Tag (Stufe 1)	A A A A A A A
Ambulant erworben frische Perforation lokalisierte Peritonitis kreislaufstabil kein MRE-Risiko (Bsp.: perforierte Cholezystitis)	3 Tage (Stufe 2)	A A A A A A A
Ambulant erworben ältere Perforation diffuse Peritonitis kreislaufstabil individuelles MRE-Risiko (Bsp.: frei perforierte Sigamdivertikulitis)	5 Tage (Stufe 3)	A A A A B
Nosokomial (postoperativ/tertiär) diffuse Peritonitis kreislaufinstabil hohes MRE-Risiko (Bsp.: Nahtleckage nach Rektumresektion)	7–10 Tage (Stufe 4)	A A A B A B

Diagnose	Therapiedauer
Nekrotisierende Pankreatitis mit infizierten Nekrosen	7–10 Tage
Intraabdominelle Mykose	≥14 Tage

?

Einzelne Infektionen

- Ausstülpung Mukosa / Submukosa durch Muskelwand im Kolon
- Jeder 3. Deutsche in seinem Leben betroffen
- **Divertikulitis:** Entzündung mit Übergriff auf Darmwand, Komplikationen: Blutung, Perforation, Fistel, Abszess

Classification of Diverticular Disease (CDD)

Typ. 0

Asymptomatische Divertikulose

Zufallsbefund; asymptomatisch

Keine Krankheit

Typ 1

Unkomplizierte Divertikelkrankheit/Divertikulitis

Typ. 1a

Divertikulitis/Divertikelkrankheit ohne phlegmonöse Umgebungsreaktion

Auf die Divertikel beziehbare Symptome

Entzündungszeichen und/oder

Entzündungsbefunde in der Bildgebung (Wandverbreiterung, entzündetes Divertikel)

Typ. 1b

Divertikulitis mit phlegmonöser Umgebungsreaktion

Entzündungszeichen; phlegmonöse Divertikulitis (Kolonwand, Mesenterium)

in der Bildgebung;

ggfs. mit Flüssigkeitsstraßen (ohne Luft)

Typ. 2

Komplizierte Divertikulitis

Typ. 2a

Mikroabszess

Gedekte Perforation, kleiner Abszess (≤ 3 cm); minimale parakolische Luft

Typ. 2b

Makroabszess

Parakolischer oder mesokolischer Abszess (> 3 cm)

Typ. 2c

Freie Perforation

Freie Perforation, freie Luft/Flüssigkeit, generalisierte Peritonitis

Typ 2c1

Eitrige Peritonitis

Typ 2c2

Fäkale Peritonitis



Multizentrisch, open label, RCT

Amoxi/Clav (7d) vs. No-antibiotics

Bei unkomplizierter Divertikulitis, CT-gesichert, entspr. 1a-b

Kriterien: Immunkompetent, Alter < 80 J, keine AB Therapie in den letzten zwei Wochen,
keine Divertikulitis Episode in der Anamnese oder ausgeprägte Komorbidität

Im Anschluss ambulante Therapie

TABLE 1. Baseline Characteristics of Patients According to Study Group

	ATB-Group (n = 238)	Non-ATB-Group (n = 242)	P
Age (yr) / Median (IQR)	57 / (19)	59 / (18)	0.13*
Gender (male: female)	120:118	104:138	0.12 [^]
Temperature (°C)/ Median (IQR)	36.3/(0.7)	36.4 / (0.8)	0.63 [']
Respiratory rate (rpm)/Median (IQR)	21/(0)	21 / (1)	0.07*
Heart rate (bpm)/ Median (IQR)	80/(16)	80 / (15)	0.31*
CRP (mg/dL)/ Median (IQR)	4.4/(5.5)	5.1 / (6.5)	0.01*
Leucocytosis (U/μL) /Mean (SD)	10,691/(2979)	10,822 / (3,023)	0.63*
Pain (VAS)/Median (IQR)	5/(3)	4 / (2)	0.07*

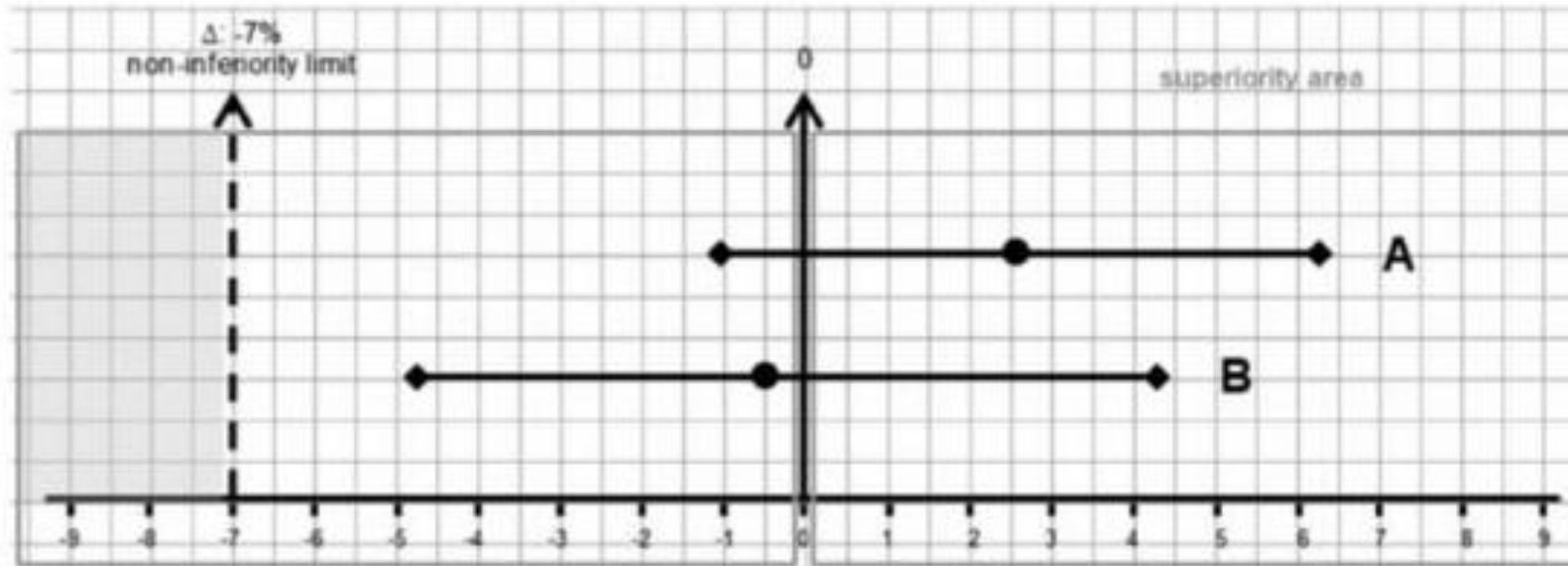
Figures shown are averages except for gender.

ATB-Group indicates control arm; CRP, C-reactive protein; IQR, interquartile range; Non-ATB-Group, experimental arm; SD, standard deviation; VAS, visual analogue scale.

*Mann-Whitney *U* test.[^]Fisher exact test.[']T-Test.

Efficacy and Safety of Nonantibiotic Outpatient Treatment in Mild Acute Diverticulitis (DINAMO-study)

A Multicentre, Randomised, Open-label, Noninferiority Trial



90-days FU	ATB-Group (%)	Non-ATB-Group (%)	p	CI 95% (ATB-Group (%) – Non-ATB-Group (%))
(A) Admission	14/238 (5.8%)	8/242 (3.3%)	0.19	2.58 (6.32 to -1.17)
(B) ED revisit	16/238 (6.7%)	17/242 (7%)	1	-0.3 (4.22 to -4.83)

A

Keine Antibiotika **nicht** unterlegen (bezogen auf Wiederaufnahme)

EMPFEHLUNG 5.20 (MODIFIZIERT 2021)

Bei akuter unkomplizierter linksseitiger Divertikulitis (CDD 1b) ohne Risikoindikatoren für einen komplizierten Verlauf kann unter engmaschiger klinischer Kontrolle auf eine Antibiotikatherapie verzichtet werden.

Evidenzlevel 1, Empfehlungsgrad 0, Starker Konsens

Classification of Diverticular Disease (CDD)

kum

Typ. 0	Asymptomatische Divertikulose	
	Zufallsbefund; asymptomatisch	Keine Krankheit
Typ 1	Unkomplizierte Divertikelkrankheit/Divertikulitis	
Typ. 1a	Divertikulitis/Divertikelkrankheit ohne phlegmonöse Umgebungsreaktion	
	Auf die Divertikel beziehbare Symptome	
	Entzündungszeichen und/oder	
	Entzündungsbefunde in der Bildgebung (Wandverbreiterung, entzündetes Divertikel)	
Typ. 1b	Divertikulitis mit phlegmonöser Umgebungsreaktion	
	Entzündungszeichen; phlegmonöse Divertikulitis (Kolonwand, Mesenterium)	
	in der Bildgebung;	
	ggfs. mit Flüssigkeitsstraßen (ohne Luft)	
Typ. 2	Komplizierte Divertikulitis	
Typ. 2a	Mikroabszess	Gedeckte Perforation, kleiner Abszess (≤ 3 cm); minimale parakolische Luft
Typ. 2b	Makroabszess	Parakolischer oder mesokolischer Abszess (> 3 cm)
Typ. 2c	Freie Perforation	Freie Perforation, freie Luft/Flüssigkeit, generalisierte Peritonitis
Typ 2c1	Eitrige Peritonitis	
Typ 2c2	Fäkale Peritonitis	

- Antibiotikaauswahl analog zu **sek. Peritonitis**
 - **Ceftriaxon / Metronidazol**
 - **Ampicillin / Sulbactam**
 - Je nach Comorbidität und Vortherapien: **Piperacillin / Tazobactam**
 - **Oral:** Amoxicillin/Clavulansäure o. Ciprofloxacin/Metronidazol

- **Therapiedauer unklar!**
- Je nach klinischem Verlauf und Manifestation (Abszess) **7(-14)d**

- Eine der häufigsten IAI Ursachen überhaupt!
- Standard in Deutschland ist die Appendektomie
- Bei unkomplizierter Infektion und OP ➔ keine AB erforderlich

- ***Antibiotics First Strategy***
 - **APPAC Trial I-III**
 - **I:** OP vs. AB (3d Ertapenem, 7d Levo/Metronidazol), ca 72% brauchen keine OP
 - **II:** Vergleich orale Regime: Moxi 7d vs Erta 2d plus Levo/Metronidazol 5d, 70% vs 74% brauchen OP in einem Jahr
 - CAVE: jüngere (!) Patienten ohne Peritonitis, Perforation, Abszess

Antibiotics versus placebo in adults with CT-confirmed uncomplicated acute appendicitis (APPAC III): randomized double-blind superiority trial

Multicenter RCT; Placebo kontrolliert
CT (!) bestätigte Appendicitis, unkompliziert (maximal 60 J, kein Abszess / Perforation / Faecolith)
10d AB (2d Ertapenem, 8d Levo / Metronidazol) vs. Placebo
Prim. Outcome: Entlassung innerhalb von 10d aus dem Krankenhaus

72 Patienten eingeschlossen: 87% (Placebo Gruppe) vs. 97% (AB Gruppe) Heilung (n.s.)

Table 2 Secondary outcomes

	Placebo group (n = 31)	Antibiotic group (n = 35)	P¶
Duration of primary hospital stay (h)*	52.0 (48.3–57.4) (n = 31)	55.5 (50.0–59.0) (n = 35)	0.161#
Duration of overall hospital stay within 10 days (h)*	52.6 (48.5–61.8) (n = 31) (n = 10)	55.5 (50.0–59.0) (n = 35) (n = 10)	0.480#
VAS score for pain†			Group 0.998 Day < 0.001 Group × day 0.164
Baseline	4.5 (3.4, 5.6) (n = 28)	5.0 (4.0, 6.0) (n = 34)	
2–4 days	0.7 (0.3, 1.0) (n = 31)	0.2 (-0.1, 0.6) (n = 31)	
10 days	0.3 (0.1, 0.6) (n = 30)	0.3 (0.04, 0.5) (n = 32)	
Duration of sick leave (days)‡	4.7 (3.6, 5.8) (n = 30)	5.3 (4.2, 6.4) (n = 30)	0.478**



- **Def.:** > 250 polymorphonukleären (PMN)-Zellen, d. h. neutrophilen Granulozyten, pro mm³ Aszites
- Entzündung des Peritoneums ohne andere Ursache (Perforation, Tumor, TBC) - im Gegensatz zur sek. Peritonitis (die aber bei Zirrhose auch vorkommen kann)
- Oft / praktisch immer: Monoinfektion; durch Translokation über die Darm-Mukosa
- **Risikofaktoren:**
 - Z.n. SBP
 - GI Blutung
 - Eiweiß im Aszites < 1,5g/dl
 - PPIs
 - Risiko steigt mit dem Fortschreiten der Zirrhose

- **Therapie: Ceftriaxon 1x2g über 5d**
 - Alternative bei V.a. MRE: Pip / Taz oder Meropenem
 - Kontrollpunkt erwägen (nach 48h / bei fehlender Besserung an d5)

- Runyon et al, 1991: RCT, 5d (47) vs. 10d (43) in SBP, keine Unterschiede in Mortalität, Rezidiv

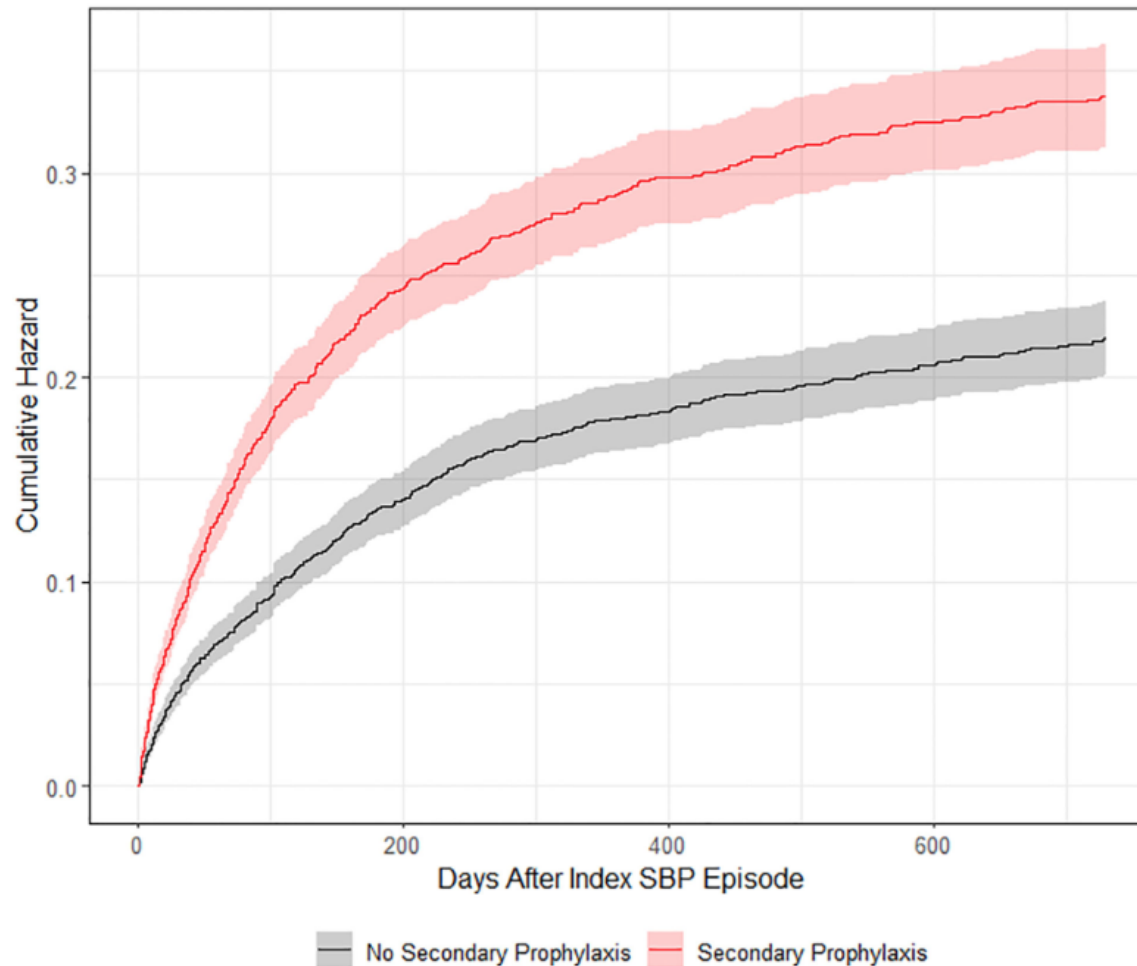
SBP - Prophylaxe

Indikationen	Empfohlene Therapie
Z.n. SBP (Sekundärprophylaxe)	Ciprofloxacin 500mg/die, Norfloxacin 400mg/die oder Cotrimoxazol 960mg/die oder Rifaximin 2x550mg
Zirrhosepatienten mit Protein im Aszites < 1,5g/dl und Niereninsuffizienz oder Child Score ≥ 9 (Primärprophylaxe)	Dauer der Therapie unklar (bis LTX? Besserung Child Stadium, Aszitesreduktion durch z.B. TIPS)

Umstritten!

Higher Rate of SBP Recurrence with Secondary SBP Prophylaxis Compared to No Prophylaxis in Two National Cirrhosis Cohorts

Retrospektive Auswertung zweier Krankenkassen-Datenbanken nach ICD Codes (überlebte SBP), 2009-2019



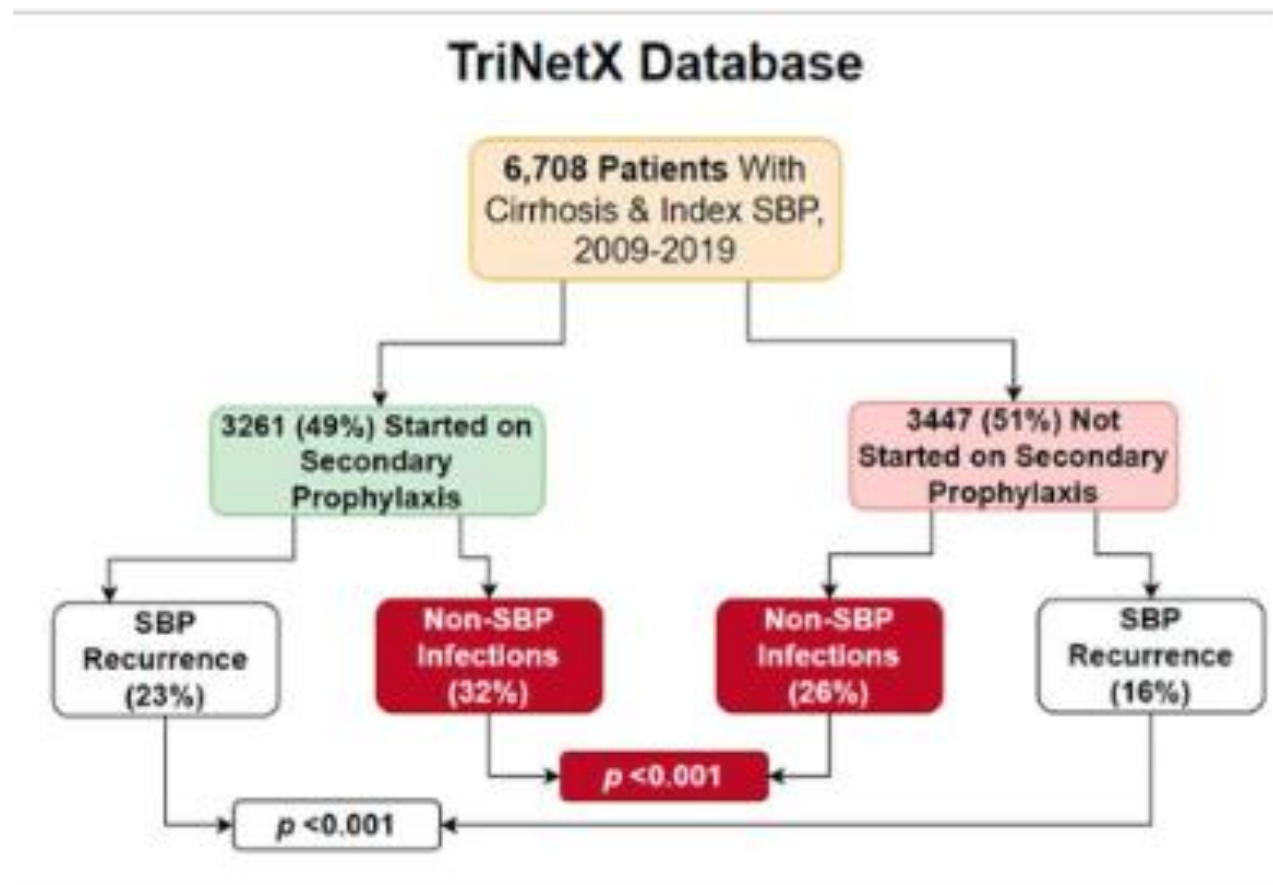
2a Mortalität 33.6 vs. 37.0%

Aber

Mehr Tx in Prophylaxegruppe, ebenso mehr Propranolol, höheres Bilirubin, niedrigere Thrombozyten, ...

Higher Rate of SBP Recurrence with Secondary SBP Prophylaxis Compared to No Prophylaxis in Two National Cirrhosis Cohorts

Retrospektive Auswertung zweier Krankenkassen-Datenbanken nach ICD Codes (überlebte SBP), 2009-2019





ASEPTIC: primary antibiotic prophylaxis using co-trimoxazole to prevent Spontaneous bacterial Peritonitis in Cirrhosis—study protocol for an interventional randomised controlled trial

Dominic Crocombe¹, Norin Ahmed², Indran Balakrishnan³, Ekaterina Bordea², Marisa Chau², Louise China¹, Lynsey Corless⁴, Victoria Danquah², Hakim-Moulay Dehbi², John F. Dillon⁵, Ewan H. Forrest⁶, Nick Freemantle², David Peter Gear⁷, Coral Hollywood⁸, Rachael Hunter², Tasheeka Jeyapalan², Yiannis Kallis⁹, Stuart McPherson¹⁰, Iulia Munteanu², Jim Portal¹¹, Paul Richardson¹², Stephen D. Ryder¹³, Amandeep Virk², Gavin Wright¹⁴ and Alastair O'Brien^{1,2,15*}

UK Studie zur Primärprophylaxe bei SBP mit Cotrimoxazol 960mg einmalig
Patienten mit Zirrhose und Aszites, die auch eine Parazentese benötigen

Untersuchung über mehrere Monate / Jahre geplant
Placebo kontrolliert

Intra-abdominal infections survival guide: a position statement by the Global Alliance For Infections In Surgery

Massimo Sartelli^{1*}, Philip Barie², Vanni Agnoletti³, Majdi N. Al-Hasan⁴, Luca Ansaloni⁵, Walter Biffi⁶, Luis Buonomo⁷, Stijn Blot⁸, William G. Cheadle⁹, Raul Coimbra^{10,11}, Belinda De Simone¹², Therese M. Duane¹³, Paola Fugazzola⁵, Helen Giamarellou¹⁴, Timothy C. Hardcastle¹⁵, Andreas Hecker¹⁶, Kenji Inaba¹⁷, Andrew W. Kirkpatrick¹⁸, Francesco M. Labricciosa¹⁹, Marc Leone²⁰, Ignacio Martin-Loeches^{21,22,23,24}, Ronald V. Maier²⁵, Sanjay Marwah²⁶, Ryan C. Maves²⁷, Andrea Mingoli²⁸, Philippe Montravers²⁹, Carlos A. Ordóñez³⁰, Miriam Palmieri¹, Mauro Podda³¹, Jordi Rello^{32,33}, Robert G. Sawyer³⁴, Gabriele Sganga³⁵, Pierre Tattevin³⁶, Dipendra Thapaliya³⁷, Jeffrey Tessier³⁸, Matti Tolonen³⁹, Jan Ulrych⁴⁰, Carlo Vallicelli⁴¹, Richard R. Watkins⁴², Fausto Catena⁴¹ and Federico Coccolini⁴³

Sartelli et al, Wordl Journal of Emerg Surgery 2024

- Personalisierte Medizin, auch bei **komplizierten** IAI
- **Fokussanierung** ist bei IAI besonders entscheidend!
- **Un**komplizierte Infektionen mit saniertem Fokus (Appendicitis, Cholezystitis) brauchen nach der OP **gar kein Antibiotikum**
- Bei **komplizierten IAI** mit adäquater Fokuskontrolle: **4d Antibiotika ausreichend** (STOP IT Trial)
- Bei **ambulant** erworbenen IAI: **Keine** Abdeckung von Candida, Enterokokken, Pseudomonas
- **Mikrobiologische Diagnostik** bei allen kompl. IAI prinzipiell sinnvoll (Epidemiologie der Resistenzprofile)
- Kalkulierte Therapie mit **Echinokandin** bei **nosokomialer** IAI insb. mit Anastomoseninsuffizienz und septischem **Schock**
- **((Deskalieren nicht vergessen!))**

*Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit*

Fragen?